

40. 実践1 結腸のフレームワーク

所要時間：03:16

学習シート

コース概要

このビデオでは、腸間膜動脈や左結腸角といった重要な支持点を介して、結腸フレームの施術が探求されています。講演者たちは、腸の運動性と精神的・感情的な側面との関連性を強調し、特定の緊張がいかに内臓下垂や内臓機能不全といった内部の不均衡を反映しうるかを示しています。腹部正常張力（normotension abdominale）の重要性が強調され、高血圧と低血圧の問題に対処しています。横行結腸と個人的な確信とのつながり、および過剰な食事が健康に与える影響についても議論され、学生やセラピストに統合的で解放的なアプローチのための鍵を提供しています。

実践1：結腸フレーム

この実践では、結腸フレームにおける重要な**支点**を探求します。

最初の支点は腸間膜動脈です。次に、**2番目の支点**は固定されている**左結腸曲**に位置します。**3番目の支点**は深部にあります。最後に、最後の支点は、逆方向に動く腸のダイナミクスに関連しています。

私たちが観察する動きは**運動性**の動きです。この時点から、**物語**をたどり始めることができます。私はすぐに**胃**、**脾臓**、そして左結腸曲に引き寄せられます。この支点は、かなり深い**精神的な平面**を再調整しています。それは、情報を再発見するために、より前方の**支点**に近づこうとしているのかもしれません。

この点は、**大動脈平面**と**脾臓平面**の間でバランスが取れています。これは統合の平面であり、表面に浮上したい無意識であり、**夢**や**悪夢**の形で表現されることがあります。支点を左側に置くことで、私はある程度の**自由**を得ようとしています。

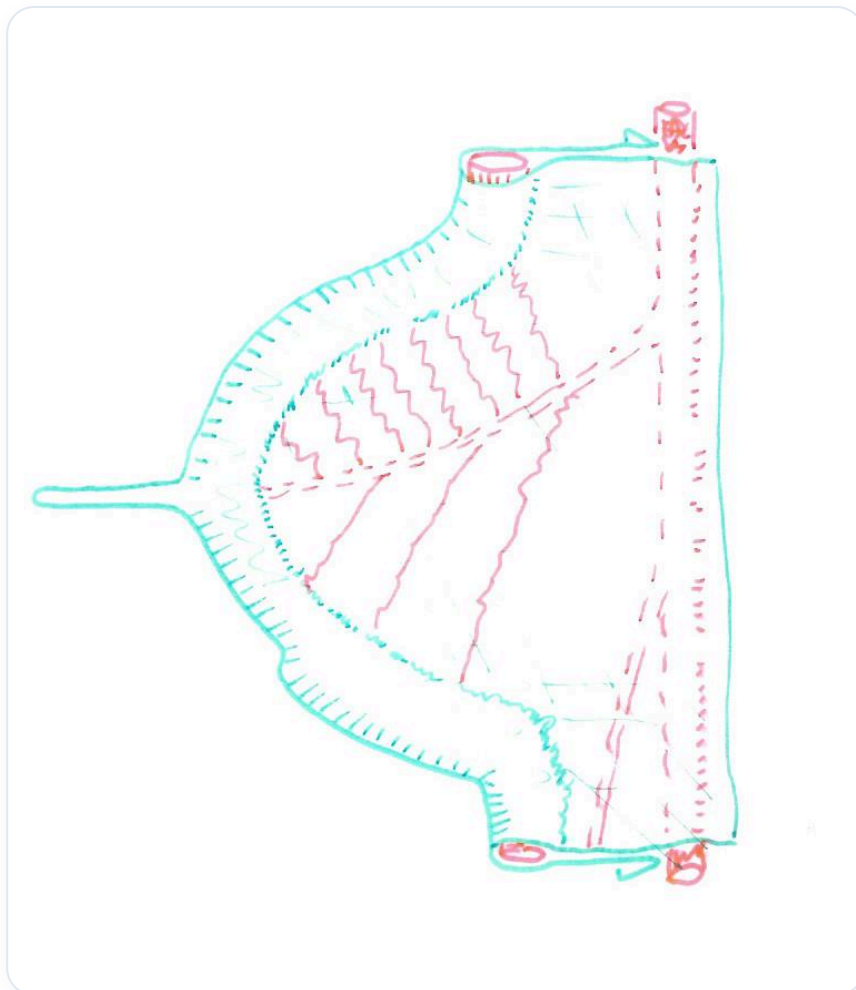
最終的な点はここにあります。通常、**上腹部緊張**は**下腹部緊張**よりもわずかに高くなければなりません。これは常に**腹部正常緊張**または**腹部低緊張**の探求です。もし、私の触診で下腹部緊張が上腹部緊張よりも高いと判断した場合、それは**下垂**のシステムを示しています。

この場合、私は**内臓空間**または流体の**再調整**システムに取り組む必要があります。**高血圧**の場合、体液を再解放する必要があります。一方、**低血圧**の場合、弛緩が必要であり、これは内臓空間システムを再統合して**ダイナミクス**を回復し、力を高めることを意味します。

過食はまだ改善できることに注意することが重要です。上昇すると、形成される角度を観察し、下降すると、私の**喜びの領域**に向かいます。問題が解決されない場合、それは**怒りの領域**につながる可能性があります。

横行結腸は、人生における私の**確信**を表しています。これらの確信が解決されない場合、それらは**疑念**に変わります。上昇すると、私の**不安**がある**信頼の領域**に直面します。ここでの角度は、解放することが不可欠な**罪悪感の足かせ**と呼ばれるものです。

最後に、下降すると、**私の独立の探求**、つまり**両親**から完全に自由になる必要があるプロセスに取り組みます。



図一 胚の消化管